

La urodinamia es un grupo de pruebas que miden qué tan bien su vejiga almacena y libera la orina. Tubos delgados y blandos (sondas) miden las presiones mientras su vejiga se llena lentamente y luego se vacía. El objetivo es recrear sus síntomas en el consultorio para que su equipo pueda encontrar la causa exacta y planificar el tratamiento adecuado.

Acerca de esta prueba

La urodinamia no es una sola prueba, sino varias que se hacen juntas. Según sus necesidades, puede incluir:

- Una **prueba de flujo** — usted orina en un inodoro especial que mide su chorro, y el equipo verifica cuánta orina queda adentro.
- Un **estudio de llenado** — la vejiga se llena lentamente mientras se miden las presiones y usted informa lo que siente.
- Un **estudio de presión-flujo** — se miden las presiones mientras usted orina.
- A veces se toman **imágenes de rayos X** al mismo tiempo (videourodinamia).

Se usan dos tubos delgados: uno en la vejiga (a través de la uretra) y un segundo, muy pequeño, en el recto (o la vagina) para medir la presión del abdomen, de modo que el equipo pueda distinguir la presión de la vejiga del esfuerzo al pujar.

¿Es seguro?

Sí. La urodinamia es una prueba interactiva de bajo riesgo. El principal riesgo proviene de las sondas — ardor breve y una pequeña posibilidad de una infección urinaria. Es posible que le den un antibiótico. No hay cirugía ni tiempo de recuperación.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Urodinamia

Un conjunto de pruebas que miden cómo la vejiga almacena y vacía la orina.

Vejiga

La bolsa muscular que almacena la orina hasta que usted orina.

Sonda

Un tubo delgado y blando que se usa para llenar la vejiga y medir la presión.

Estudio de llenado

Mide la presión y la sensación a medida que la vejiga se llena lentamente.

Estudio de presión-flujo

Mide la presión mientras usted orina, para ver cómo se vacía la vejiga.

Prueba de flujo

Mide la velocidad y el patrón de su chorro de orina.

Videourodinamia

La misma prueba con imágenes de rayos X añadidas para más detalle.

Orina residual posmiccional

La cantidad de orina que queda en la vejiga después de que usted orina.

¿LE DOLERÁ? La mayoría de las personas sienten presión y algo de vergüenza por las sondas, más que dolor real. Le pedirán que tosa, cambie de posición y orine durante la prueba — el equipo lo mantiene cubierto y trabaja a su ritmo. Por lo general toma unos 30–60 minutos, y usted puede irse a casa de inmediato.

Cómo prepararse (antes de su prueba)

- Es posible que le pidan llegar con la **vejiga cómodamente llena** — siga las instrucciones que le den.
- Tome sus **medicinas habituales**, pero pregunte si debe **suspender alguna medicina para la vejiga** de antemano, ya que pueden cambiar los resultados.
- No se necesita sedación, así que por lo general puede **manejar usted mismo de regreso a casa**.

Avise a su equipo con anticipación si usted:

- Tiene signos de una **infección urinaria** (ardor, fiebre, u orina turbia o con olor fuerte) — una infección activa puede hacer que la prueba se re programe
- Toma un anticoagulante, o tiene alguna alergia (incluido el látex)

Es posible que le pidan dar una **muestra de orina** para detectar infección antes de la prueba.

Qué sucede durante la prueba

- 1 Usted orina en un inodoro especial que mide su chorro, y el equipo verifica cuánta orina queda adentro.
- 2 Se colocan suavemente sondas delgadas — una en la vejiga y una pequeña en el recto o la vagina.
- 3 La vejiga se llena lentamente mientras usted informa cuándo siente por primera vez que se llena y cuándo siente una urgencia fuerte; es posible que le pidan toser o cambiar de posición.
- 4 Usted orina mientras se registran las presiones, y luego se retiran las sondas.

Después de la prueba

- Puede volver a sus **actividades normales de inmediato**.
- Puede sentir **ardor leve al orinar** durante un día o algo así. Tomar agua extra ayuda y alivia esto.
- Puede notar un **tono rosado** en la orina por un tiempo corto. Esto es común y suele desaparecer en un día.

Llame al consultorio de su cirujano o busque atención si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Dificultad para orinar, o no puede orinar en absoluto
- Sangrado abundante, o coágulos de sangre en la orina
- Dolor que empeora en lugar de mejorar

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La urodinamia mide cómo se llena y se vacía su vejiga para que su equipo pueda encontrar la causa de los escapes, la urgencia o la dificultad para vaciar — y planificar el tratamiento adecuado.
2. Hay poco que hacer para prepararse. Pregunte si debe suspender alguna medicina para la vejiga, llegue con la vejiga cómodamente llena si se lo piden, y avise a su equipo sobre signos de una infección.
3. Espere presión más que dolor, y váyase a casa de inmediato. Es normal tener ardor leve o un poco de tono rosado en la orina durante un día — tome agua extra, y llame si tiene fiebre, sangrado abundante o dificultad para orinar.